



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN PELAYANAN
UNIT INTENSIVE
2025**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko, Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang
Nomor : 319.42/I-PDM/ICU/IV/2025

Tentang

Pedoman Pelayanan Unit Intensive

Disusun oleh :
Ka Instalasi ICU



(dr. Heru Wicaksono Sp A)

Disetujui oleh :
Authorized Person



(Dr. dr Aslichah, M. Kes AFP.)

Ditetapkan oleh :
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Nur Mazidah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Pedoman Pelayanan Unit Intensive dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS. Prima Husada Malang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Pedoman Pelayanan Unit Intensive ini, mutu sumber daya manusia di Rumah Sakit Prima Husada Malang dapat lebih baik.

Malang, 04 April 20
Direktur RS Prima Husada



dr. Nur Mazidah

TIM PENYUSUN

1. dr. Resti Lestantini, M. Kes
2. dr. Heru Wicaksono, Sp AN
3. Ns. Risma Indra Setiyani, S. Kep
4. Ns. Rita Purnama Sari, S. Kep
5. Ns. Artika Wulandari, S. Kep
6. Ns. Tatik Widayati, S. Kep

DAFTAR ISI

SAMPUL i

PENGESAHAN ii

KATA PENGANTAR..... iii

TIM PENYUSUN iv

DAFTAR ISI v

PERATURAN DIREKTUR..... vi

BAB I HIGH CARE UNIT (HCU)

 1.1 Pendahuluan 1

 1.1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Tujuan 2

 1.3 Sasaran 2

 1.4 Ruang Lingkup 2

 1.5 Pengertian 2

BAB II PENYELENGGARAAN PELAYANAN HCU

 2.1 Pelayanan HCU 3

 2.2 Ketenagaan 4

 2.3 Sarana, Prasarana, dan Peralatan..... 4

 2.4 Alur Pelayanan 5

 2.5 Indikasi Masuk dan Keluar 6

 2.6 Pencatatan dan Pelaporan 6

BAB III INTENSIVE CARE UNIT (ICU)

 3.1 Pendahuluan

 3.1.1 Latar Belakang 8

 3.2 Tujuan 8

 3.3 Ruang Lingkup Pelayanan..... 9

 3.4 Batasan Oprasional 9

 3.5 Sasaran 10

 3.6 Pengertian 10

BAB IV STANDART FASILITAS

 4.1 Standart Fasilitas 11

BAB V KEMAMPUAN PELAYANAN

 5.1 Pelayanan ICU yang bisa dilakukan di RSPH 12

 5.2 Kemampuan pelayanan 12

BAB VI TATA LAKSANA PELAYANAN

 6.1 Penyelenggaraan Pelayanan ICU 13

 6.2 Asas Prioritas..... 14

 6.3 Edukasi..... 14

 6.4 Asuhan Pasien Di Ruang Intensive Care Unit (ICU) 14

 6.5 Indikasi Keluar Masuk ICU..... 15

6.6 Pencatatan Dan Pelaporan	16
6.7 Rujukan Pasien.....	16
6.8 Transport Pasien	17
BAB VII LOGISTIK	18
BAB VII STANDAR KETENAGAAN	
8.1 Kualifikasi Sumber Daya Manusia.....	19
8.2 Distribusi Ketenagaan.....	19
8.3 Pengaturan Jaga	20
BAB IX KESELAMATAN PASIEN	
9.1 Pengertian	21
9.2 Tujuan	21
9.3 Standar Keselamatan Pasien.....	21
9.4 Kejadian – Kejadian Yang Dapat Muncul Dalam Pelayanan	21
9.5 Tata Laksana Keselamatan Pasien.....	22
9.6 Tata Laksana Pada Pasien Unit Intensive.....	23
BAB X KESELAMATAN KERJA	
10.1 Latar Belakang	25
10.2 Pengertian	25
10.3 Tujuan	25
10.4 Tata Laksana Keselamatan Karyawan.....	25
10.5 Prinsip Keselamatan Kerja.....	26
BAB XI PENINGKATAN MUTU	
11.1 Prinsip	27
11.2 Definisi Indikator	27
11.3 Kriteria	27
11.4 Standar	27
BAB X PENUTUP	29

DAFTAR BAGAN

- 1. Bagan 1. Alur Pelayanan HCU (High Care Unit) 6
- 2. Bagan 2 : Alur pasien dari dan keluar ke ICU (Intensive Care Unit) .. 14



PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

NOMOR : 319.42/I-PDM/ICU/IV/2025

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN *INTENSIVE CARE UNIT* (ICU)

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka menjamin kualitas pelayanan dan keselamatan yang efektif dan efisien bagi pasien Unit Intensive di rumah sakit
 - Bahwa dengan ditetapkannya pedoman pelayanan Unit Intensive di rumah sakit dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1778/Menkes/SK/XII/2010 perlu disusun petunjuk teknis sebagai acuan pelaksanaan, pengembangan dan evaluasi pelayanan Unit Intensive di rumah sakit
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruh a dan b perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang petunjuk teknis penyelenggaraan Unit Intensive di rumah sakit
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
 - Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1778/MENKES/SK/XII/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan *Intensive Care Unit* (ICU) di Rumah Sakit;
 - Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 390/I-KEP/DIR/V/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada
 - Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1042.92/DPMI-KEP/DIR/IX/2025 tentang Pengangkatan PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PEDOMAN PELAYANAN UNIT INTENSIVE**

**BAB I
HIGH CARE UNIT (HCU)**

Pasal 1



- (1) *High Care Unit* (HCU) adalah bagian dari bangunan rumah sakit dengan katagori pelayanan kritis, selain Instalasi Bedah, Instalasi Gawat Darurat, dan Intensive Care Unit.
- (2) Model Ruang HCU di Rumah Sakit Prima Husada adalah model Integrated yaitu bergabung dengan ruang ICU.
- (3) Rumah sakit menetapkan regulasi tentang kriteria yang ditetapkan untuk masuk rawat di pelayanan HCU.
- (4) HCU adalah Ruang Intensive penerima rujukan pasien dari Rumah Sakit lain sesuai dengan standar dan fasilitas yang dimiliki dan bila pasien memerlukan perawatan intensive yang lebih pasien di pindahkan ke ICU atau dapat di rujuk ke rumah sakit lain sesuai dengan kondisi Pasien.

Pasal 2

- (1) Kriteria dokter HCU adalah telah mengikuti pelatihan / pendidikan perawatn ICU dan telah mendapatkan sertifikat Intensive Care Medicine (KIC, Konsultan Intensive Care) melalui program pelatihan dan pendidikan yang diikuti oleh perhimpunan profesi yang terkait.
- (2) Staf yang ada di HCU adalah staf yang berkompeten dan terlatih.

Pasal 3

- (1) Ada pembayaran Done Payment (DP) kepada pasien selama perawatan 5 hari kedepan bagi pasien Umum

Pasal 4

- (1) Indikasi pemeriksaan laboratorium dan radiologi berdasarkan permintaan dari DPJP (Dokter penanggung Jawab Pasien) atau dokter konsulen lain.
- (2) Setiap permintaan laboratorium dan radiologi di input oleh staf untuk selanjutnya di informasikan pada bagian terkait.

BAB II

KRITERIA KELUAR MASUK HCU

Pasal 5

- (1) Ada kriteria dan keluar HCU, unit spesialisasi lain ruang perawatan paliatif untuk memenuhi kebutuhan pasien berdasarkan atas kriteria prioritas, diagnostik, parameter obyektif, serta kriteria berbasis fisiologi dan kualitas hidup (quality of life).
- (2) Staf yang kompeten dan berwenang dari unit intensif atau unit spesialisasi terlibat dalam menentukan kriteria.
- (3) Staf terlatih untuk melaksanakan kriteria.
- (4) Pasien yang membutuhkan perawatan di HCU dan atau keluarganya harus mendapatkan penjelasan serta memberikan persetujuan untuk dirawat di HCU
- (5) Catatan medis pasien yang diterima masuk atau keluar dari HCU atau unit spesialisasi memuat bukti bahwa pasien memenuhi kriteria masuk atau keluar

Pasal 6

- (1) Kriteria masuk HCU : pasien gagal organ yang berpotensi mempunyai resiko tinggi untuk terjadi komplikasi dan tidak



memerlukan monitor dan alat bantu invasif, pasien yang memerlukan pengawasan perioperatif.

- (2) Kriteria keluar HCU : pasien yang tidak lagi membutuhkan pemantauan yang ketat, pasien yang cenderung memburuk dan memerlukan pemantauan dan alat bantu invansive sehingga perlu pindah ke ICU.
- (3) Yang tidak perlu masuk HCU: pasien dengan fase terminal suatu penyakit (seperti: kanker stadium akhir).
- (4) Pasien / keluarga yang menolak untuk dirawat di HCU (atas dasar Infrom Consent)

BAB IV KETENTUAN HIGH CARE UNIT

Pasal 7

- (1) Setiap penggunaan peralatan medis di ruang HCU di informasikan kepada penanggung jawab pasien.
- (2) Pemantauan pasien fungsi pernapasan dan sirkulasi dengan interval waktu minimal 3 (tiga) jam atau di sesuaikan dengan kondisi pasien, oksigenasi dengan menggunakan oksimeter secara terus menerus, untuk keseimbangan Cairan dengan interval waktu minimal 7 (tujuh) jam atau sesuai dengan kondisi pasien.
- (3) Ada pemeriksaan thorax terlebih dahulu sebelum masuk HCU dan dinyatakan bersih oleh dokter jaga IGD atau dokter ruangan atau DPJP.

Pasal 8

- (1) Pasien yang dirawat di ruang High Care Unit tidak diperbolehkan untuk di dampingi maupun di kunjungi selama di rawat di ruangan , apabila terjadi perubahan kondisi pasien staf wajib memberikan informasi kepada keluarga.

Pasal 9

- (1) Tindakan yang bersifat kedokteran harus di kerjakan oleh tenaga medis tetapi dengan mempertimbangan yang memperhatikan keselamatan pasien tindakan tertentu dapat didelegasikan kepada tenaga kesehatan non medis yang terlatih.
- (2) Pada keadaan darurat, untuk kepentingan terbaik pasien, dokter Jaga Ruangan dapat melakukan tindakan kedokteran yang di perlukan dan informasi dapat diberikan pada kesempatan pertama.
- (3) Pada pasien yang berada dalam tahap terminal dan tindakan resusitasi diketahui tindak akan menyembuhkan atau memperbaiki kualitas hidup pasien, dokter dapat membuat kuputusan untuk tidak melakukan resusitasi.

BAB V INTENSIVE CARE UNIT

Pasal 10

- (1) *Intensive Care Unit* (ICU) adalah bagian dari bangunan rumah



sakit dengan katagori pelayanan kritis, selain instalansi bedah, instalasi gawat darurat, dan High Care Unit

- (2) Rumah sakit menetapkan regulasi tentang kriteria yang ditetapkan untuk masuk rawat di pelayanan ICU
- (3) HCU adalah ruangan intensive penerima rujukan pasien dari rumah sakit lain sesuai dengan standart dan fasilitas yang dimiliki dan bila pasien memerlukan perawatan intensive yang lebih tinggi tingkatannya dapat di rujuk ke rumah sakit lain sesuai denfan kondisi pasien.

Pasal 11

- (1) Kriteria dokter ICU adalah telah mengikuti pelatihan / pendidikan perawatan ICU dan telah mendapat sertifikat Intensive care Medicine (KIC, Konsultan Intensive Care) melalui program pelatihan dan pendidikan yang diikuti olehperhimpunan profesi yang terkait.
- (2) Staf yang ada di ICU adalah staf yang berkompeten dan terlatih

Pasal 12

- (1) Ada pembayaran *Done Payment* (DP) kepada pasien selama perawatan 5 hari kedepan bagi pasien umum.

Pasal 13

- (1) Indikasi pemeriksaan laboratorium dan radiologi berdasarkan permintaan dari DPJP (Dokter penanggung Jawab Pasien) atau dokter konsulen lain berkoordinasi dengan dokter penanggung jawab ICU.
- (2) Setiap permintaan laboratorium dan radiologi di input oleh staf untuk selanjutnya di informasikan pada bagian terkait.

BAB VI

KRITERIA KELUAR MASUK ICU

Pasal 14

- (1) Ada kriteria masuk dan keluar ICU, unit spesialistik lain, ruang perawatan paliatif untuk memenuhi kebutuhan pasien berdasar atas kriteria prioritas, diagnostik, parameter objektif, serta kriteria berbasis fisiologi dan kualitas hidup (*quality of life*).
- (2) Staf yang kompeten dan berwenang dari unit intensif atau unit spesialistik terlibat dalam menentukan kriteria.
- (3) Staf terlatih untuk melaksanakan kriteria.
- (4) Pasien yang membutuhkan perawatan di *Intensive Care Unit* (ICU) dan atau keluarganya harus mendapatkan penjelasan serta memberikan persetujuan untuk dirawat di ICU.
- (5) Catatan medis pasien yang diterima masuk di atau keluar dari unit intensif atau unit spesialistik memuat bukti bahwa pasien memenuhi kriteria masuk atau keluar.

Pasal 15

- (1) Ada peraturan tentang kriteria masuk dan keluar ICU yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1, meliputi:



- a. Kriteria masuk ICU: Prioritas 1 :Pasien yang mengalami gangguan akut pada organ vital yang memerlukan tindakan dan terapi yang intensif cepat yaitu utamanya pada pasien dengan Sistem Cardiovascular, Sistem Pernafasan, Sistem Saraf. Prioritas 2 :Pasien yang memerlukan pemantauan alat canggih utamanya pada pasien yang mengalami pasca pembedahan mayor, Prioritas 3 :Pasien yang dalam kondisi kritis dan tidak stabil yang mempunyai harapan kecil untuk disembuhkan atau manfaat dari tindakan yang didapat sangat kecil. Pasien ini hanya memerlukan terapi intensif pada penyakit akutnya tetapi tidak dilakukan intubasi atau Resusitasi Kardiopulmoner.
- b. Yang menentukan pasien bisa masuk ICU adalah dokter kepala ICU.
- c. Apabila ICU dalam keadaan kosong, maka semua dokter diperkenankan untuk merawat pasien di ruang ICU sesuai dengan kriteria pasien masuk ICU berdasarkan Prioritas 1, 2, 3 diatas.
- d. Kriteria keluar ICU: Pasien stabil tidak perlu pemantauan ketat (C, A, B). Pasien meninggal, dan pasien rujuk.
- e. yang tidak perlu masuk ICU; Fase terminal (Kanker stadium akhir), pasien dan keluarga menolak untuk dirawat di ICU.

BAB VII

KETENTUAN INTENSIVE CARE UNIT

Pasal 16

- (1) Bed pasien ICU disisakan satu bed yakni dengan maksud tujuan menyediakan tempat jika ada pasien yang akan melakukan operasi besar.
- (2) Setiap penggunaan peralatan medis di ruang ICU diinformasikan kepada penanggung jawab pasien.
- (3) Ada pemeriksaan thorax terlebih dahulu sebelum masuk ICU dan dinyatakan bersih oleh dokter jaga IGD atau dokter ruangan dan atau DPJP.

Pasal 17

- (1) Pasien yang dirawat di ruang *Intensif Care Unit* tidak diperbolehkan untuk di dampingi maupun dikunjungi selama dirawat di ruangan, apabila terjadi perubahan kondisi pasien staf wajib memberikan informasi kepada keluarga

Pasal 18

- (1) Tindakan yang bersifat kedokteran harus dikerjakan oleh tenaga medis tetapi dengan pertimbangan yang memperhatikan keselamatan pasien tindakan tertentu dapat didelegasikan kepada tenaga kesehatan non medis yang terlatih.
- (2) Pencatatan nilai – nilai pengukuran tanda vital secara berkala di lakukan perawat ICU 1 jam sekali dengan interval di sesuaikan dengan kondisi pasien



- (3) Pemantauan secara umum dan khusus. Setiap pagi hari oleh dokter jaga dan perawat ICU dan dikoordinasikan dengan dokter DPJP.
- (4) Pada keadaan darurat, untuk kepentingan terbaik pasien, dokter jaga ICU atau dokter spesialis anestesi dapat melakukan tindakan kedokteran yang diperlukan dan informasi dapat diberikan pada kesempatan pertama.
- (5) Pada pasien yang berada dalam tahap terminal dan tindakan resusitasi diketahui tidak akan menyembuhkan atau memperbaiki kualitas hidup pasien, dokter dapat membuat keputusan untuk tidak melakukan resusitasi

BAB VIII

RUJUKAN KELUAR

Pasal 19

- (1) Rumah Sakit memiliki staf terlatih yang mengelola rujukan.
- (2) Rumah Sakit bekerja sama dengan Rumah Sakit rujukan.
- (3) Rumah Sakit melakukan rujukan sesuai dengan kebutuhan pasien untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di Rumah Sakit Rujukan.

BAB IX

KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 04 April 2025
Direktur RS Prima Husada



dr. Nur Mazidah

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT PRIMA HUSADA

NOMOR: 319.42/I-PDM/ICU/IV/2025

TENTANG PEDOMAN PELAYANAN
UNIT INTENSIVE

PEDOMAN PELAYANAN UNIT INTENSIVE

BAB I

HIGH CARE UNIT (HCU)

1.1 Pendahuluan

1.1.1 Latar Belakang

Bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus di wujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya. Peningkatan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di Rumah Sakit secara terus menerus ditingkatkan sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran. Pengembangan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit juga di arahkan guna meningkatkan mutu dan keselamatan pasien serta efisiensi biaya dan kemudahan akses segenap masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pelayanan High Care Unit (HCU) di Rumah Sakit perlu ditingkatkan secara berkesinambungan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan pengobatan, perawatan dan pemantauan secara ketat yang semakin meningkat sebagai akibat penyakit menular maupun tidak menular seperti : demam berdarah, malaria, cedera, keracunan, penyalahgunaan NAPZA, HIV, penyakit jantung pembuluh darah, diabetes mellitus, dan gagal ginjal.

Petunjuk teknis ini disusun sebagai acuan bagi Rumah Sakit dalam rangka penyelenggaraan pelayanan HCU yang berkualitas dan mengedepankan keselamatan pasien di Rumah Sakit serta dalam penyusunan standar prosedur operasional pelayanan HCU di Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum :

Meningkatkan mutu pelayanan dan kesehatan pasien yang di rawat di HCU.

1.2.2 Tujuan Khusus :

- 1) Menyediakan, meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia.
- 2) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan pelayanan HCU terutama bagi pasien kritis stabil yang hanya membutuhkan pelayanan

pemantauan.

- 3) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan pelayanan HCU terutama bagi pasien kritis stabil yang hanya membutuhkan pelayanan pemantauan.

1.3 Ruang Lingkup

Pelayanan HCU diberikan kepada pasien dengan kondisi kritis stabil yang membutuhkan pelayanan, pengobatan dan pemantauan secara ketat tanpa penggunaan alat bantu (misalnya ventilator) dan terapi titrasi.

1.4 Sasaran

- 1) Dokter dan perawat serta tenaga kesehatan lainnya yang memberikan layanan HCU.
- 2) Direktur Rumah Sakit

1.5 Pengertian

High Care Unit (HCU) adalah unit pelayanan di Rumah Sakit bagi pasien dengan kondisi stabil dengan fungsi respirasi, hemodinamik, dan kesadaran namun masih memerlukan pengobatan, perawatan dan pemantauan secara ketat. Tujuannya adalah agar bias diketahui secara dini perubahan-perubahan yang membahayakan, sehingga bias dengan segera di pindah ke ICU untuk di kelola lebih baik lagi.

Pasien yang dimaksud tersebut adalah pasien yang memerlukan tingkat pelayanan yang berada di antara ICU dan ruang rawat inap biasa (artinya tidak perlu perawatan ICU namun belum dapat dirawat di ruang rawat inap biasa karena masih memerlukan pemantauan yang ketat)

Waktu penyelenggaraan pelayanan HCU berlangsung selama 24 jam sehari selama 7 hari per minggu.

Ada 3 (tiga) tipe HCU, yaitu :

- 1) Separated/ conventional/ freestanding HCU adalah HCU yang berdiri sendiri (*independent*), terpisah dari ICU.
- 2) Integrated HCU adalah HCU yang menjadi satu dengan ICU.
- 3) Paralel HCU adalah HCU yang terletak berdekatan (bersebelahan) dengan ICU.

PENYELENGGARAAN PELAYANAN HCU

Penyelenggaraan pelayanan HCU memperhatikan ketersediaan SDM, Kesehatan, sarana, prasarana, dan peralatan di rumah sakit serta beban kerja pelayanan; memperhatikan tata letak ruangan / bangunan dan kemudahan akses dengan unit pelayanan lain yang terkait.

2.1 Pelayanan HCU

Pelayanan HCU adalah tindakan medis yang dilaksanakan melalui pendekatan tim multidisiplin yang dipimpin oleh dokter spesialis yang telah mengikuti pelatihan dasar – dasar ICU. Anggota tim terdiri dari dokter spesialis dan dokter serta perawat yang bekerja secara interdisiplin dengan focus pelayanan pengutamaan pada pasien yang membutuhkan pengobatan, perawatan dan pemantauan secara ketat sesuai dengan standard prosedur oprasional yang berlaku di Rumah Sakit Prima Husada.

Pelayanan HCU meliputi pemantauan pasien secara ketat, menganalisis hasil pemantauan dan melakukan tindakan medik dan asuhan keperawatan yang diperlukan.

Ruang lingkup pemantauan yang harus dilakukan antara lain :

- 1) Tingkat keasadaaran.
- 2) Fungsi pernapasan dan sirkulasi dengan interval waktu minimal 3 (tiga) jam atau disesuaikan dengan keadaan pasien.
- 3) Oksigenasi dengan menggunakan oksimeter secara terus menerus.
- 4) Keseimbangan cairan dengan interval waktu minimal 7 (tujuh) jam atau disesuaikan dengan keadaan pasien.

Tindakan medic dan asuhan keperawatan yang dilakukan adalah:

- 1) Bantuan Hidup Dasar/ Basic Life Support (BHD/ BLS) dan Bantuan Hidup Lanjut/ Advanced Life Support (BHD/ ALS)
 - a. Jalan nafas (Airway): membebaskan jalan nafas, bila perlu menggunakan alat bantu jalan nafas, seperti pipa oropharingeal atau pipa nosopharingeal. Dokter HCU juga harus mampu melakukan Intubasi endotrakea bila diindikasikan segera memindahkan/ merejuk pasien ke ICU.
 - b. Pernafasan/ ventilasi (Breathing); mampu melakukan bantuan nafas (breathing support) dengan bag-mask-valve.
 - c. Sirkulasi (Circulation); resusitasi cairan, tindakan defibrilasi, tindakan kompresi jantung luar.

2) Terapi Oksigen

Memberikan oksigen sesuai kebutuhan pasien dengan berbagai alat pengalir oksigen, seperti : kanul nasal, sungkup muka sederhana, sungkup muka dengan reservoir, sungkup muka dengan katup dan sebagainya.

- 3) Penggunaan obat – obatan untuk pemeliharaan/ stabilisasi (obat inotropik, obat anti nyeri, obat aritmia jantung, obat – obat yang bersifat vasoaktif, dan lain – lain).

- 4) Nutrisi enteral atau nutrisi parenteral campuran.
- 5) Fisioterapi sesuai dengan keadaan pasien.
- 6) Evaluasi seluruh tindakan dan pengobatan yang telah diberikan.

2.2 Ketenagaan

Tenaga yang terlibat dalam pelayanan HCU terdiri dari tenaga dokter spesialis, dokter dan perawat. Tenaga tersebut melaksanakan pelayanan HCU sesuai dengan kompetensi dan kewenangan yang diatur oleh Rumah Sakit Prima Husada. Adapun susunan tim pelayanan HCU adalah sebagai berikut:

- 1) Koordinator : Dokter Spesialis yang telah mengikuti pelatihan dasar – dasar ICU, yang meliputi:
 - a. Pelatihan pemantauan
 - b. Pelatihan penatalaksanaan jalan nafas dan terapi oksigen
 - c. Pelatihan terapi cairan, elektrolit, dan asam basa
 - d. Pelatihan pencegahan dan pengendalian infeksi
 - e. Pelatihan manajemen HCU
- 2) Anggota:
 - a. Dokter spesialis/ dokter yang telah mengikuti pelatihan Basic dan Advanced Life Support.
 - b. Perawat yang telah mengikuti pelatihan Basic Life Support dan dapat melakukan pemantauan menggunakan peralatan monitor.

Jumlah dokter spesialis, dokter dan perawat disesuaikan dengan jam kerja pelayanan HCU 24 jam, beban kerja dan kompleksitas kasus pasien yang membutuhkan pelayanan HCU. Rasio jumlah perawat berbanding pasien di HCU sebaiknya adalah 1 (satu) perawat 2 (dua) pasien.

SDM pelayanan HCU diharuskan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan guna mempertahankan dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan.

Program pelatihan harus diselenggarakan bagi semua staf agar dapat meningkatkan dan menambah pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam menerapkan prosedur serta pengetahuan dan teknologi baru.

2.3 Sarana, Prasarana, dan Peralatan

- 1) Lokasi :

Model Ruang HCU di Rumah Sakit Prima Husada adalah model Integrated yaitu bergabung dengan ruang ICU.

- 2) Kebutuhan Ruangan

- a. Area Pasien :

Terdiri dari 2 bed pasien tiap bed di batasi oleh tirai untuk menjaga privasi

tiap pasien dan dilengkapi hand sainsaizer untuk cuci tangan.

Pencahayaan cukup adekuat untuk observasi klinis dengan lampu TL day light 10 watt/m². Jendela dan akses tempat tidur menjamin kenyamanan pasien dan personil.

b. Area kerja meliputi :

Ruang yang cukup untuk staf dan dapat menjaga kontak visual perawat dengan pasien, ruangan cukup untuk memonitor pasien, peralatan resusitasi dan penyimpanan obat dan alat.

a) Lingkungan

Mempunyai pendingin ruangan / AC yang dapat mengontrol suhu dan kelembapan sesuai dengan luas ruangan. Suhu 22 -25 °C kelembapan 50 – 70 %

b) Ruang penyimpanan peralatan dan barang bersih

Untuk menyimpan monitor, pompa infus dan pompa syring, alat – alat sekali pakai, cairan, penggantung infus, troli, alat isap, linen dan tempat penyimpanan barang dan alat bersih

c) Spoel hox

Ruang untuk membersihkan alat – alat, pengosongan dan pembersihan pispot dan urinal, desain unit menjamin tidak ada kontaminasi

d) Ruang Staff

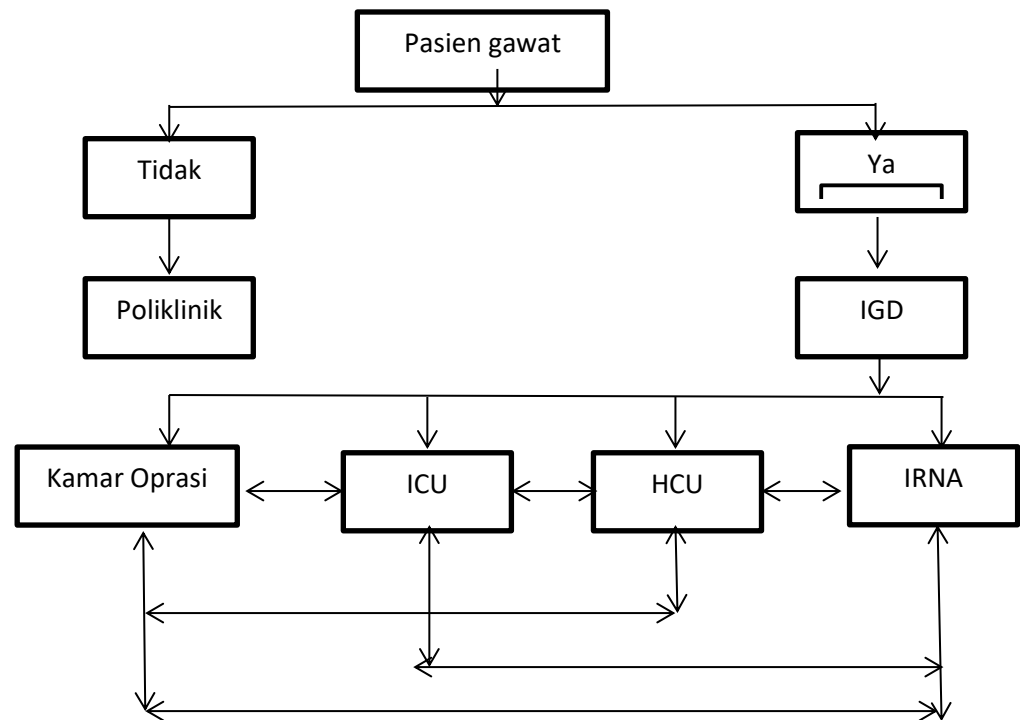
Terdapat ruang terpisah yang dapat digunakan oleh staf yang bertugas

2.4 Alur Pelayanan

Pasien yang memerlukan pelayanan HCU sesuai indikasinya adalah:

- 1) Pasien dari ICU
- 2) Pasien dari IGD
- 3) Pasien dari Kamar operasi atau kamar tindakan lain, seperti : kamar bersalin.
- 4) Pasien dari rawat inap.

Bagan 1. Alur Pelayanan HCU di Rumah Sakit Prima Husada



2.5 Indikasi Masuk dan Keluar

Penentuan indikasi pasien yang masuk ke HCU dan keluar HCU serta pasien yang tidak untuk dirawat di HCU ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1) Indikasi Masuk

- Pasien gagal organ yang berpotensi mempunyai resiko tinggi untuk terjadi komplikasi dan tidak memerlukan monitor dan alat bantu invasif (ventilator)
- Pasien yang memerlukan perawatan dan pengawasan perioperative.

2) Indikasi Keluar

- Pasien yang tidak lagi membutuhkan pemantauan yang ketat.
- Pasien yang cenderung memburuk dan/ atau memerlukan pemantauan dan alat bantu invasive sehingga perlu pindah ke ICU.

3) Yang tidak perlu masuk HCU

- Pasien dengan fase terminal suatu penyakit (seperti kanker stadium akhir)
- Pasien / keluarga yang menolak untuk dirawat di HCU (atas dasar “ Informed Consent”).

2.6 Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dan pelaporan di pelayanan HCU meliputi pencatatan rekam medis, pencatatan rekam medis pelayanan HCU sangat di butuhkan oleh Tim untuk pemantauan dan evaluasi yang berkesinambungan dan sebagai dasar pertimbangan keputusan untuk melakukan tindakan medis serta kepentingan peridungan hukum bagi dokter / dokter spesialis.

Rekam medis HCU dapat menggunakan model rekam medis ICU atau pemantauan dan intervensi yang dilakukan sesuai kebutuhan pasien.

INTENSIVE CARE UNIT (ICU)

3.1 PENDAHULUAN

3.1.1 Latar Belakang

Bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya

Peningkatan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di Rumah Sakit secara terus menerus ditingkatkan sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran. Pengembangan pelayanan kesehatan di Rumah sakit juga diarahkan guna meningkatkan mutu dan keselamatan pasien serta efisiensi biaya dan kemudahan akses segenap masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Salah satu pelayanan di Rumah Sakit adalah pelayanan *Intensive*. Saat ini pelayanan di *Intensive Care Unit* (ICU) tidak terbatas hanya untuk menangani pasien pasca bedah saja, tetapi juga meliputi berbagai jenis pasien dewasa, anak, yang mengalami lebih dari satu disfungsi organ atau gagal organ. Kelompok pasien ini dapat berasal dari Unit Gawat Darurat, Kamar Operasi, Ruang Rawat Inap, ataupun dari kiriman dari Rumah Sakit lain. *Intensive Care Unit* (ICU) adalah suatu bagian dari Rumah Sakit yang terpisah, dengan staf khusus yang ditujukan untuk observasi, rawat dan terapi pasien yang menderita penyakit, cedera atau penyulit- penyulit yang mengancam jiwa atau potensial mengancam jiwa. ICU menyediakan kemampuan, sarana dan prasarana serta peralatan khusus untuk menunjang fungsi-fungsi vital dengan menggunakan keterampilan staf medis, perawat dan staf lain yang berpengalaman dalam pengelolaan keadaan-keadaan tersebut. Keadaan yang sedemikian akan tercapai bila tenaga-tenaga yang terampil, profesional dan bermutu. Ruang lingkup pelayanan meliputi pemberian dukungan fungsi organ- organ vital seperti pernafasan, kardiovaskular, susunan saraf pusat, renal dan lain-lainnya. Mengingat diperlukannya tenaga-tenaga khusus dan terbatasnya sarana serta mahalnya peralatan yang diperlukan di Instalasi Care Unit Rumah Sakit maka perlu disusun Pedoman Pelayanan Instalasi Care Unit di Rumah Sakit yang diharapkan bisa sebagai panduan semua pihak yang terlibat didalamnya

3.2 Tujuan Pelayanan Intensive Care Unit (ICU)

3.2.1 Tujuan Umum

Meningkatkan pelayanan yang bermutu dan mengutamakan keselamatan pasien

3.2.2 Tujuan Khusus

- 1) Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di instalasi *Intensive Care Unit* dengan mutu tinggi serta mengutamakan keselamatan pasien
- 2) Pelayanan kesehatan di *Intensive Care Unit* dapat berjalan dengan baik berdasarkan standard prosedur operasional (SPO) sehingga keselamatan pasiendapat dimaksimalkan.
- 3) Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dengan pengutamaan pada upaya preventif dan kuratif.

-
- 4) Menciptakan *Intensive Care Unit* dengan pelayanan yang nyaman dan lingkunganyang aman.

3.3 Ruang Lingkup Pelayanan

Pelayanan *Intensive Care Unit* (ICU) diberikan kepada pasien dengan kondisi kritis stabil yang membutuhkan pelayanan, pengobatan dan observasi secara ketat

3.4 Batasan Oprasional

Pelayanan ICU diindikasikan dan ditentukan oleh kebutuhan pasien yang sakit kritis :

- 1) Pasien-pasien yang secara fisiologis tidak stabil dan memerlukan penanganan dokter, perawat, profesi lain yang terkait secara terkoordinasi dan berkelanjutan, serta pemantauan dan penanganan segera, terapi titrasi dan dukungan alat.
- 2) Keadaan pasien dalam bahaya dan mengalami dekompensasi fisiologis sehingga memerlukan pemantauan ketat dan terus menerus serta intervensi segera dan dukungan peralatan canggih untuk mencegah timbulnya penyulit yang merugikan. Pada keadaan permintaan layanan ICU lebih tinggi dari pada kapasitas atau sarana dan prasarana maka kepala ICU harus menentukan prioritas sesuai indikasi.

Prioritas tersebut adalah:

a. Pasien prioritas 1 (satu)

Kelompok ini dengan kondisi sakit kritis, tidak stabil, memerlukan bantuan ventilasi dan alat bantu suportif organ/sistem yang lain, infus obat-obat kontinyu, misalnya pasca bedah kardiorasik, pasien sepsis berat, gangguan keseimbangan asam basa dan elektrolit yang mengancam nyawa.

b. Pasien prioritas 2 (dua)

Pasien ini memerlukan pelayanan karena sangat berisiko bila tidak mendapatkan terapi intensive dan pemantauan segera.

c. Pasien prioritas 3 (tiga)

Pasien golongan ini adalah pasien sakit kritis, yang tidak stabil status kesehatan sebelumnya, penyakit yang mendasarinya, atau penyakit akutnya, secara sendirian atau kombinasi. Kemungkinan sembuh dan/atau manfaat terapi di ICU pada golongan ini sangat kecil. Pengelolaan pada pasien golongan ini hanya untuk mengatasi kegawatan akutnya saja, dan usaha terapimungkin tidak sampai melakukan intubasi atau resusitasi jantung paru.

d. Pengecualian

Dengan pertimbangan dan persetujuan Kepala ICU, indikasi masuk pada beberapa golongan pasien bisa dikecualikan, dengan catatan bahwa pasien- pasien golongan demikian sewaktu waktu harus bisa dikeluarkan dari ICU agar fasilitas ICU yang terbatas tersebut dapat digunakan untuk pasien prioritas 1, 2, 3 (satu, dua, tiga). Pasien yang tergolong demikian antaralain:

- a) Pasien yang memenuhi kriteria masuk tetapi menolak terapi tunjangan hidup yang agresif / "DNR (*Do Not Resuscitate*)".
- b) Pasien dalam keadaan vegetatif permanen Pasien yang telah dipastikan mengalami mati batang otak.
- c) Pasien seperti itu dapat dimasukkan ke ICU untuk menunjang fungsi

-
- organ hanya untuk kepentingan donor organ.
- d) Pasien pada tahap terminal

3.5 Sasaran

1. Direktur Rumah Sakit
2. Dokter dan perawat dan tenaga kesehatan lainnya yang memberikan layanan ICU

3.6 Pengertian

Pelayanan *Intensive Care* adalah pelayanan rumah sakit yang diperuntukkan dan ditentukan oleh kebutuhan pasien yang sangat kritis. Tujuan dari pelayanan intensive care adalah memberikan pelayanan medik, tertitrasi dan berkelanjutan.

Pelayanan ICU harus dilakukan oleh intensivis yang terlatih secara formal dan mampu memberikan pelayanan yang optimal dan terbebas dari tugas – tugas lain yang membebani seperti kamar operasi, praktek dan tugas – tugas kantor. Intensivist yang bekerja harus berpartisipasi dalam sistem yang menjamin kelangsungan pelayanan intensive care 24 jam.

Hubungan pelayanan ICU yang terorganisir dengan bagian – bagian pelayanan lain di Rumah Sakit harus ada dalam organisasi Rumah Sakit.

BAB IV STANDART FASILITAS

4.1 Standart Fasilitas

4.1.1 Fasilitas & Sarana

ICU RS Prima Husada berlokasi di lantai I gedung utama yang terdiri dari 8 bed pasien yang masing-masing bed terdapat monitor sebagai alat observasi.

4.1.2 Peralatan

Peralatan yang tersedia di ICU mengacu kepada KMK RI NOMOR 834/MENKES/SK/VII/2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan *Pelayanan Intensive Care Unit* (ICU) sebagai penunjang kegiatan pelayanan terhadap pasien Gawat darurat.

Alat-alat yang digunakan di ICU

1. Pasien Monitor (yang bisa memonitor tekanan darah, *heart rate* secara berkala, EKG dan oksimetri)
2. Defibrilator
3. Alat penghisap lendir (Suction Pump, Sentral atau Manual)
4. Alat pembebas jalan nafas (Laringoskop, pipa endotracheal dll)
5. Alat akses pembuluh darah
6. Pompa infus (infusion pump/ syringe pump)
7. Alat transportasi pasien.
8. Ventilator

BAB V

KEMAMPUAN PELAYANAN

5.1 Pelayanan ICU yang bisa dilakukan di RSPH

1. Pasien yang memerlukan intervensi medis segera
2. Pasien yang memerlukan pengelolaan fungsi sistem organ tubuh secara terkoordinasi dan berkelanjutan sehingga dapat dilakukan pengawasan yang konstan terus menerus dan metode terapi titrasi
3. Pasien sakit kritis yang memerlukan pemantauan kontinyu dan tindakan segera untuk mencegah timbulnya dekompensasi fisiologis

5.2 Kemampuan pelayanan

No	Kemampuan pelayanan		
	Primer	Tersier	Sekunder
1	Resusitasi jantung paru	Resusitasi jantung paru	Resusitasi jantung paru
2	Pengelolaan jalan nafas, termasuk intubasi trakeal dan ventilasi mekanik	Pengelolaan jalan nafas, termasuk intubasi trakeal dan ventilasi mekanik	Pengelolaan jalan nafas, termasuk intubasi trakeal dan ventilasi mekanik
3	Terapi oksigen	Terapi oksigen	Terapi oksigen
4	Pemasangan kateter vena sentral	Pemasangan kateter vena sentral dan arteri	Pemasangan kateter vena sentral, arteri, swan ganz dan ICP monitor
5	Pemasangan EKG, pulsoksimetri dan tekanan darah non invasif	Pemasangan EKG, pulsoksimetri dan tekanan darah non invasif dan invasif	Pemantauan EKG, pulsoksimetri, tekanan darah non invasif dan invasif swan ganz dan ICP serta ECHO monitor
6	Pelaksanaan terapi secara titrasi	Pelaksanaan terapi secara titrasi	Pelaksanaan terapi secara titrasi
7	Pemberian nutrisi enteral dan parenteral	Pemberian nutrisi enteral dan parenteral	Pemberian nutrisi enteral dan parenteral
8	Pemeriksaan laboratorium khusus dengan cepat dan menyeluruh	Pemeriksaan laboratorium khusus dengan cepat dan menyeluruh	Pemeriksaan laboratorium khusus dengan cepat dan menyeluruh
9	Fungsi vital dengan alat portable selama transportasi pasien gawat	Memberikan tunjangan fungsi vital dengan alat-alat portable selama transportasi pasien gawat	Memberikan tunjangan fungsi vital dengan alat-alat portable selama transportasi pasien gawat
10	Kemampuan melakukan fisioterapi dada	Melakukan fisioterapi dada	

BAB VI

TATA LAKSANA PELAYANAN

6.1 Penyelenggaraan Pelayanan ICU

Penyelenggaraan pelayanan ICU harus memperhatikan ketersediaan SDM kesehatan, sarana, prasarana dan peralatan yang tersedia di rumah sakit serta beban kerja pelayanan, memperhatikan tata letak ruangan/bangunan dan kemudahan akses dengan unit pelayanan lain yang terkait

6.1.1 Pelayanan ICU adalah tindakan medis yang dilaksanakan melalui pendekatan tim multidisiplin yang terdiri dari dokter spesialis dan dokter umum serta dibantu oleh perawat yang bekerja secara interdisiplin dengan fokus pelayanan pengutamaan pada pasien yang membutuhkan pengobatan, perawatan dan observasi secara ketat sesuai dengan standart prosedur operasional yang berlaku di Rumah Sakit. Pelayanan ICU meliputi pemantauan pasien secara ketat, menganalisis hasil pemantauan dan melakukan tindakan medik dan asuhan keperawatan.

Ruang lingkup pemantauan yang harus dilakukan antara lain :

- 1) Tingkat kesadaran
- 2) Fungsi pernafasan dan sirkulasi dengan interval waktu minimal 4 (empat) jam atau disesuaikan dengan keadaan pasien.
- 3) Oksigenasi dengan menggunakan oksimeter secara terus menerus
- 4) Keseimbangan cairan dengan interval waktu minimal 7 (tujuh) jam atau disesuaikan dengan keadaan pasien.

Tindakan medik dan asuhan keperawatan yang dilakukan adalah :

- 1) Bantuan Hidup dasar/ Basic Life Support (BHD/BLS) dan Bantuan Hidup Lanjut/Advance Life Support (BHL/ALS)
 - a. Jalan nafas (Airway)
Memberikan jalan nafas (sampai dengan melakukan intubasi endotrakeal)
 - b. Pernafasan/ ventilasi (Breathing)
Mampu melakukan bantuan nafas (breathing support)
 - c. Sirkulasi
- 2) Mampu melakukan resusitasi cairan
- 3) Mampu melakukan defibrilasi
- 4) Mampu melakukan kompresi jantung luar
- 5) Terapi oksigen
- 6) Penggunaan obat-obatan untuk pemeliharaan/stabilisasi
- 7) Nutrisi enteral atau parenteral
- 8) Fisioterapi sesuai dengan keadaan pasien
- 9) Evaluasi seluruh tindakan dan pengobatan yang telah diberikan.

6.1.2 Alur pelayanan

Pasien yang mendapatkan pelayanan ICU dapat berasal dari

- 1) Pasien dapat berasal dari IGD
- 2) Pasien dapat berasal dari IKO
- 3) Pasien dapat berasal dari IRNA

6.2 Asas Prioritas

Setiap dokter primer dapat mengusulkan agar pasiennya bisa dirawat di ICU asalkan sesuai dengan indikasi masuk yang benar. Mengingat keterbatasan ketersediaan fasilitas di ICU, maka berlaku prioritas dan keputusan akhir merupakan kewenangan penuh kepala ICU.

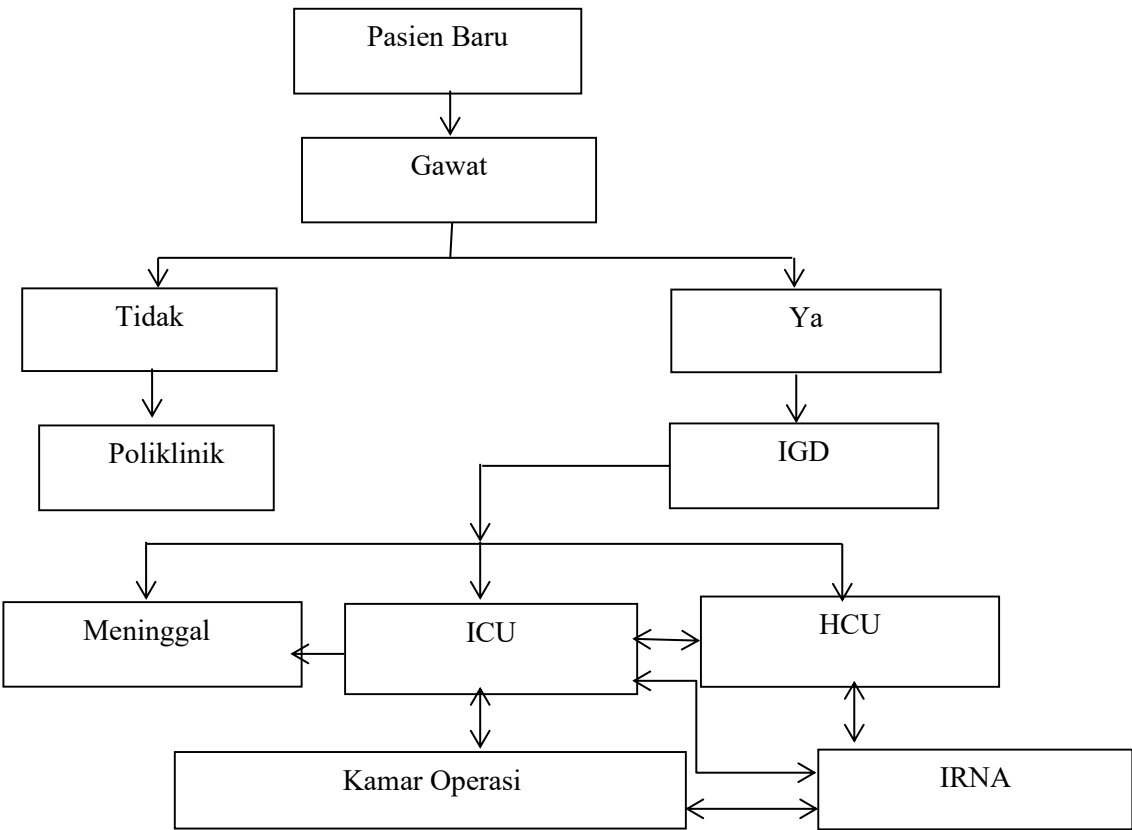
6.3 Edukasi

Sebelum pasien dimasukkan ke ICU, pasien dan atau keluarganya harus mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang dasar pertimbangan mengapa pasien harus mendapatkan perawatan di ICU, serta berbagai tindakan kedokteran yang mungkin akan dilakukan selama pasien dirawat di ICU serta prognosa penyakit yang diderita pasien. Penjelasan tersebut diberikan oleh Kepala ICU atau dokter yang bertugas. Setelah mendapatkan penjelasan tersebut, pasien dan atau keluarganya bisa menerima atau tidak bisa menerima pernyataan pasien dan atau keluarganya (baik bisa menerima atau tidak bisa menerima) harus dinyatakan dalam formulir yang ditanda-tangani (lembar edukasi) seperti terlampir.

6.4 Asuhan Pasien Di Ruang Intensive Care Unit (ICU)

Saat diputuskan pasien masuk di ruang ICU, dokter yang memutuskan rawat inap memberi informasi tentang rencana asuhan yang diberikan, hasil asuhan yang diharapkan, termasuk penjelasan oleh petugas pendaftaran tentang perkiraan biaya yang harus dibayarkan oleh pasien / keluarga dan pemberian informasi di dokumentasikan. Selama perawatan diruang Intensif Care Unit (ICU), pasien tidak diperbolehkan untuk di dampingi maupun dikunjungi selama dirawat, terkecuali apabila terjadi perubahan kondisi pasien perawat wajib memberikan informasi kepadakeluarga

Bagan 2 : Alur pasien dari dan keluar ke ICU (Intensive Care Unit)



6.5 Indikasi Keluar Masuk ICU

Penentuan indikasi pasien yang masuk ke ICU dan keluar dari ICU serta pasien yang tidak dianjurkan untuk dirawat di ICU ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut

6.5.1 Kriteria masuk ICU

1. **Prioritas 1** : Pasien yang mengalami gangguan akut pada organ vital yang memerlukan tindakan dan terapi yang intensif cepat yaitu utamanya pada pasien :

(1) `Sistem Cardiovasculer :

- a. *Acute Coronary Syndrome* (ACS) : tanpa atau dengan komplikasi dan mungkin disertai penyakit penyerta lainnya
- b. Syok Cardiogenik
- c. Kegawatan irama jantung
- d. Gagal jantung dan paru akut
- e. Kegawatan hipertensi disertai kegawatan cardiovasculer
- f. Kegawatan penyakit jantung katup
- g. Kegawatan penyakit jantung kongenital
- h. Kegawatan vaskuler (diseksi aorta, emboli paru, sumbatan pembuluh darah vena dalam dan arteri perifer)
- i. Kegawatan kardiovaskuler lainnya (endokarditis, miokarditis, tamponade jantung, trauma jantung)
- j. Pasien kardiovaskuler yang memerlukan pemantauan hemodinamik untuk evaluasi terapi
- k. Serangan asma berat
- l. Status epileptikus
- m. Anemia gravis dengan hemodinamik tidak stabil
- n. Bronkopneumonia dengan hemodinamik tidak stabil
- o. Kelainan jantung kritikal
- p. Gagal jantung pada anak
- q. Kegawatan jantung yang diakibatkan oleh syok hipovolemik yang mengakibatkan hemodinamik tidak stabil

(2) Sistem Pernafasan

Pneumonia, COPD, asma, TBC yang sudah terjadi komplikasi sampai ke syoksepsis, dan ada gagal nafas dengan atau tanpa menggunakan ventilator mekanik

(3) Sistem Syaraf

- 1) CVA *Bleeding* dengan penurunan kesadaran tanpa adanya tindakan *trepanasi*
- 2) CVA *Trombosis* yang meluas disertai dengan penurunan kesadaran
- 3) GBS (Guillain Barre syndrome) dengan gejala sesak nafas dengan atau tanpa penggunaan ventilator mekanik

2. **Prioritas 2** : Pasien yang memerlukan pemantauan alat canggih utamanya pada pasien yang mengalami pasca pembedahan mayor.

3. **Prioritas 3** : Pasien yang dalam kondisi kritis dan tidak stabil yang mempunyai harapan kecil untuk disembuhkan atau manfaat dari tindakan yang didapat sangat kecil. Pasien ini hanya memerlukan terapi intensif pada penyakit akutnya tetapi tidak dilakukan intubasi atau Resusitasi Kardiopulmoner.

1) Yang menentukan pasien bisa masuk ICU adalah dokter kepala ICU.

2) Apabila ICU dalam keadaan kosong, maka semua dokter diperkenankan untuk merawat pasien di ruang ICU sesuai dengan kriteria pasien masuk ICU berdasarkan Prioritas 1, 2, 3 diatas.

6.5.2 Kriteria Keluar

- 1) Pasien sudah stabil yang tidak lagi membutuhkan pemantauan yang ketat tentang pernafasan (C,A,B).
- 2) Pasien meninggal
- 3) Pasien di Rujuk
- 4) Pulang Paksa

Untuk pasien Pulang Paksa dari runag ICU, pihak Rumah Sakit tidak memfasilitasi transportasi untuk pengantaran pasien pulang.

6.5.3 Yang tidak perlu masuk ICU

- 1) Pasien dengan fase terminal suatu penyakit (seperti kanker stadium akhir)
- 2) Pasien/keluarga yang menolak untuk dirawat di ICU (atas dasar penolakan diform edukasi)

6.6 Pencatat Dan Pelaporan

1. Pencatatan nilai-nilai pengukuran tanda vital secara berkala dilakukan oleh perawat ICU 1 jam sekali dengan interval disesuaikan dengan kondisi pasien.
2. Pemantauan secara umum dan khusus. setiap pagi hari oleh dokter jaga dan perawat ICU dan dikoordinasikan dengan dokter DPJP .

Pemantuan umum meliputi:

- a. Pemeriksaan tanda - tanda vital, meliputi pemeriksaan tensi, nadi, suhu, respirasi, saturasi oksigen.
- b. Pemeriksaan fisik meliputi sistem syaraf, sistem kardiovaskular, sistem respirasi, sistem gastrointestinal, sistem tractus urinarius dan sistem lokomotif.
- c. Balance cairan dilakukan setiap 7 jam selama shift kerja dan diakumulasikan dalam 24 jam, diperhitungkan intake dan output cairan.
- d. Pemeriksaan Laboratorium meliputi :
 - 1) Analisa gas darah
 - 2) Gula darah
 - 3) Darah rutin
 - 4) Elektrolit
 - 5) Ureum, kreatinin
 - 6) Keton darah sesuai indikasi
 - 7) Keton urine sesuai indikasi
 - 8) Hemostase lengkap sesuai indikasi
 - 9) SGOT SGPT sesuai indikasi, dsb

6.7 Rujukan Pasien

Pasien dirujuk ke fasilitas kesehatan lain didasarkan atas kondisi pasien dan kebutuhan untuk memperoleh asuhan berkesinambungan. Rujukan pasien antara lain untuk memenuhi kebutuhan pasien atau konsultasi spesialisik dan tindakan, serta penunjang diagnostik.

Rujukan ke fasilitas kesehatan lain dengan atau tanpa ada perjanjian formal dengan ketentuan :

1. Rujukan pasien dilakukan sesuai dengan kebutuhan kesinambungan asuhan pasien.
2. Rumah sakit yang merujuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan yang menerima dapat memenuhi kebutuhan pasien yang dirujuk.

3. Ada kerjasama rumah sakit yang merujuk dengan rumah sakit yang menerima.

Ketentuan seperti ini dapat memastikan kesinambungan asuhan tercapai dan kebutuhan pasien terpenuhi. Diperlukan proses konsisten melakukan rujukan pasien untuk memastikan keselamatan pasien yaitu:

1. Ada staf yang bertanggung jawab dalam pengelolaan rujukan termasuk untuk memastikan pasien diterima di rumah sakit rujukan yang dapat memenuhi kebutuhan pasien.
2. Selama dalam proses rujukan ada staf yang kompeten sesuai dengan kondisi pasien yang selalu memonitor dan mencatatnya dalam rekam medis.
3. Dilakukan identifikasi kebutuhan obat, bahan medis habis pakai, alat kesehatan dan peralatan medis yang dibutuhkan selama proses rujukan
4. Dalam proses pelaksanaan rujukan, ada proses serah terima pasien antara staf pengantar dan yang menerima.

6.8 Transport Pasien

Proses merujuk, memindahkan, dan memulangkan pasien membutuhkan pemahaman tentang kebutuhan transpor pasien. Bergantung pada kebijakan rumahsakit dan peraturan perundang-undangan apakah ongkos transpor dapat atau tidak menjadi tanggung jawab rumah sakit. Jenis kendaraan untuk transportasi berbagai macam, mungkin ambulans atau kendaraan lain milik rumah sakit atau berasal dari sumber yang diatur oleh keluarga atau teman. Jenis kendaraan yang diperlukan bergantung pada kondisi dan status pasien.

Kendaraan transportasi milik rumah sakit harus tunduk pada peraturan perundangandan memenuhi ketentuan antara lain:

1. Alat transportasi pasien harus sesuai dengan kebutuhannya yang meliputi asesmen kebutuhan transportasi, obat, bahan medis habis pakai, serta alat kesehatan dan peralatan medis sesuai dengan kebutuhan pasien.
2. Alat transportasi yang digunakan untuk rujukan harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien dan memenuhi ketentuan keselamatan transportasi termasuk memenuhi persyaratan PPI.
3. Bila alat transportasi yang digunakan terkontaminasi cairan tubuh pasien atau pasien dengan penyakit menular harus dilakukan proses dekontaminasi.
4. Ada mekanisme untuk menangani keluhan proses transportasi yang mengatur tentang kegiatan operasionalnya, kondisi, dan perawatan kendaraan.

Pengelolaan obat dan alat kesehatan / alkes meliputi pemesanan, pengambilan, penyimpanan dan pencatatan obat / alkes untuk pasien – pasien ICU. Mekanisme pengadaan obat dan alat medis di ICU adalah sebagai berikut :

1. Persiapan alat
 - a. Buku Peminjaman keluar/ masuk alat
 - b. Buku inventaris alat
 - c. Blanko pemesanan bahan habis pakai dan alkes
2. Setiap hari petugas pagi menyeterilkan alat ke instalasi dan mengambil kembali setelah disterilkan untuk disimpan pada tempatnya.
3. Pemesanan bahan habis pakai kesehatan dilakukan oleh perawat penanggung jawab dinas pagi setiap jam kerja dari jam 10.00 s/d 12.00 dengan mengisi blanko SPB (Surat Permintaan Barang) yang ditandatangani Kepala ICU dengan jumlah yang sesuai pengeluaran / kebutuhan. Pemesanan terakhir ditutup 3 hari sebelum akhir bulan

BAB VIII

STANDAR KETENAGAAN

8.1 Kualifikasi Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan pelayanan Unit Intensive dilaksanakan oleh tenaga medis profesional yang berwenang berdasarkan undang-undang, memenuhi persyaratan baik dari aspek hukum, strata pendidikan, kualitas maupun kuantitas dengan jaminan kepastian adanya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap keprofesian terus menerus dalam rangka menjaga mutu profesi dan kepuasan pelanggan. Kualitas dan rasio kuantitas harus disesuaikan dengan beban kerja dan keluasan cakupan pelayanan serta perkembangan dan visi rumah sakit. Dalam menyelenggarakan pelayanan ICU dan HCU dilakukan oleh tim terdiri dari dokter Spesialis dan dokter umum serta dibantu oleh perawat. Tim pelayanan ICU dan HCU tersebut telah mendapatkan pelatihan dasar ICU tersebut telah mendapatkan pelatihan dasar ICU yang diselenggarakan oleh organisasi profesi. Adapun susunan tim pelayanan ICU dan HCU adalah:

Tenaga profesi yang bertugas di dalam pelayanan intensive care unit RS Prima Husada memiliki persyaratan sebagai berikut:

- 1. Pelayanan intensive care unit Rumah Sakit Prima Husada dipimpin oleh dokter spesialis anesthesiologi.
- 2. Pelayanan diselenggarakan oleh tenaga medis perawat yang mempunyai pelatihan bantuan hidup dasar dan bantuan hidup lanjut.
- 3. Keperawatan telah terdaftar di Kementrian kesehatan dan telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR).
- 4. Kepala intensive care unit bertanggung jawab terhadap segala aspek hukum dan peraturan-peraturan baik terhadap kelancaran tugas dalam shift maupun tindakan-tindakan keperawatan sesuai SPO.
- 5. Setiap saat harus ada kepala intensive care unit di tempat pelayanan untuk melangsungkan dan mengawasi pelayanan medis dan harus ada pendelegasian wewenang yang bertanggung jawab bila perawat berhalangan.
- 6. Adanya uraian tugas bagi karyawan dan pimpinan keperawatan.
- 7. Adanya karyawan medis yang jumlah dan kualifikasinya disesuaikan dengan kebutuhan.
- 8. Penilaian terhadap karyawan harus dilakukan berdasarkan tugas yang terkait dengan pekerjaan fungsional yang diberikan dan juga pada penampilan kerja yang dihasilkan dalam meningkatkan mutu pelayanan.

8.2 Distribusi Ketenagaan

Standar pelayanan Unit Intensive pada rumah sakit tipe C terdiri dari :

NAMA JABATAN	WAKTU KERJA	JUMLAH SDM
Kepala Instalasi ICU	1 shift	1 orang
Kepala ruang ICU	1 shift	1 orang
Perawat Pelaksana	1 shift	11 orang
Tenaga non medis	1 shift	1 orang

8.3 Pengaturan Jaga

Pengaturan jaga di Unit Intensive Rumah Sakit Prima Husada adalah sebagai

berikut :

NAMA JABATAN	WAKTU KERJA	DEFINISI WAKTU KERJA	JUMLAH SDM
Kepala Instalasi ICU	1 shift	08.00-16.00	1 orang
Kepala Unit ICU	1 shift	06.30-15.00	1 orang
Perawat Pelaksana	3 shift	06.30-14.30 14.00-21.30 21.00-07.00	11 orang
Tenaga non medis	3 shift	06.30-14.30 14.00-21.30 21.00-07.00	2 orang

BAB IX

KESELAMATAN PASIEN

9.1 Pengertian

Keselamatan Pasien (Patient Safety) adalah suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman.

Sistem tersebut meliputi :

1. Asesmen resiko
 2. Identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien
 3. Pelaporan dan analisis insiden
 4. Kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya
 5. Implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko
- Sistem ini mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh :
1. Kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan
 2. Tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil

9.2 Tujuan

1. Terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit
2. Meningkatkan akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat
3. Menurunkan Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) di rumah sakit
4. Terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan Kejadian Tidak Diharapkan (KTD)

9.3 Standar Keselamatan Pasien

1. Hak pasien
2. Mendidik pasien dan keluarga
3. Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan
4. Penggunaan metoda-metoda peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien
5. Mendidik staf tentang keselamatan pasien
6. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien
7. Komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien

9.4 Kejadian – Kejadian Yang Dapat Muncul Dalam Pelayanan

1. Kejadian Tidak Diharapkan (KTD)
 - a. KTD yang dapat dicegah (Adverse Event) :

Adalah suatu kejadian yang tidak diharapkan, yang mengakibatkan cedera pasien akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil, dan bukan karena penyakit dasarnya atau kondisi pasien. Cedera dapat diakibatkan oleh kesalahan medis atau bukan kesalahan medis karena tidak dapat dicegah
 - b. KTD yang tidak dapat dicegah (Unpreventable Adverse Event) :

Suatu KTD yang terjadi akibat komplikasi yang tidak dapat dicegah dengan pengetahuan mutakhir
2. Kejadian Nyaris Cedera (KNC) Near Miss :

Adalah suatu kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan (commission) atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil (omission), yang dapat mencederai pasien, tetapi cedera serius tidak terjadi :

- Karena “ keberuntungan”
 - Karena “ pencegahan ”
 - Karena “ peringatan ”
3. Kesalahan Medis Medical Errors:
Adalah kesalahan yang terjadi dalam proses asuhan medis yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera pada pasien
 4. Kejadian Sentinel Sentinel Event :
Adalah suatu KTD yang mengakibatkan kematian atau cedera yang serius; biasanya dipakai untuk kejadian yang sangat tidak diharapkan atau tidak dapat diterima, seperti : operasi pada bagian tubuh yang salah.
Pemilihan kata “sentinel” terkait dengan keseriusan cedera yang terjadi (seperti, amputasi pada kaki yang salah) sehingga pencarian fakta terhadap kejadian ini mengungkapkan adanya masalah yang serius pada kebijakan dan prosedur yang berlaku.

9.5 TATA LAKSANA KESELAMATAN PASIEN

1. Mengidentifikasi pasien dengan benar
 - a. Setiap pasien yang masuk rawat inap dipasang gelang identitas pasien.
 - b. Gelang identitas untuk pasien laki-laki berwarna biru muda dan gelang identitas untuk perempuan berwarna merah muda. Bila pasien ada resiko jatuh diberi stiker warna kuning dan bila pasien ada alergi diberi stiker warna merah.
 - c. Ada 2 identitas yang digunakan, yaitu nama dan tanggal lahir yang disesuaikan dengan tanda pengenal resmi.
 - d. Identifikasi digunakan sebelum pemberian obat, sebelum pemberian transfusi darah, sebelum pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan radiologi, sebelum dilakukan tindakan medis.
2. Meningkatkan komunikasi yang efektif
Menggunakan teknik SBAR (*Situation, Background, Assesment, Recommendation*) dalam melaporkan kondisi pasien untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antar pemberilayanan.
 - a. *Situation*
Kondisi terkini yang terjadi pada pasien.
 - b. *Background*
Informasi penting apa yang berhubungan dengan kondisi pasien terkini.
 - c. *Assesment*
Hasil pengkajian kondisi pasien terkini.
 - d. *Recommendation*
Apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah pasien saat ini. Dalam melakukan verifikasi terhadap akurasi dari komunikasi lisan dengan *writeback, readback* dan *reconfirm*.
3. Meningkatkan keamanan obat-obat yang harus diwaspadai (*HIGH ALERT Medications*)
 - a. Obat-obat *high alert* tidak disimpan di ruang rawat inap.
 - b. Obat-obat NORUM / LASA dapat ditemukan di daftar obat NORUM /LASA.
 - c. Obat-obat emergensi disimpan dalam box emergensi terkunci & dipastikan selalu tersedia dan harus diganti segera jika jenis & jumlahnya sudah tidak

sesuai lagi dengan daftar yang ditempel dalam box emergensi. Perbekalan farmasi & penguncian box dikontrol oleh farmasi & kepala instalasi.

- d. Penyediaan obat dilakukan oleh apoteker. Petugas farmasi menyediakan obat setiap hari & dibedakan menurut jam pemberian obat sehingga memudahkan perawat untuk memberikan obat ke pasien.
 - e. Pemberian obat harus memperhatikan 7 benar : Benar pasien, Benar Indikasi, Benar Obat, Benar Dosis, Benar cara pemberian, Benar waktu pemberian dan Benar dokumentasi.
4. Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar
Penandaan lokasi operasi oleh dokter operator yang dilakukan di ruangan pasien sebelum dilakukan operasi (untuk operasi terencana). Bila operasi dilakukan segera (dari IGD), penandaan bisa dilakukan di ruang premedikasi.
 5. Mengurangi resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan.
Untuk mengurangi resiko infeksi, semua petugas di rumah sakit melakukan kebersihan tangan pada 5 momen yang telah ditentukan, yaitu:
 - a. Sebelum kontak dengan pasien
 - b. Sesudah kontak dengan pasien
 - c. Sebelum tindakan aseptis
 - d. Sesudah terkena cairan tubuh pasien
 - e. Sesudah kontak dengan lingkungan sekitar pasien.

Ada 2 cara cuci tangan yang digunakan:

- a. Handwash
 - 1) Dengan air mengalir
 - 2) Waktunya 40 – 60 detik
 - b. Hand rub
 - 1) Dengan air berbasis alkohol
 - 2) Waktunya 20 – 30 detik
6. Mengurangi resiko cedera pasien akibat terjatuh
 - a. Setiap tempat tidur di pasang pagar pengaman.
 - b. Setiap pasien dilakukan penilaian resiko jatuh dengan menggunakan metode *Morse Fall Scale, Humty Dumty Scale, Ontario Modified Stratify – Sydney Scoring*
 - c. Pengkajian resiko jatuh dilakukan oleh perawat dan kemudian dapat dijadikan dasar pemberian rekomendasi kepada dokter untuk tata laksana lebih lanjut.
 - d. Perawat memasang stiker berwarna kuning pada gelang identitas pasien dan tanda resiko pasien jatuh ditempat tidur bila pasien beresiko jatuh dan memberitahu pasien dan atau keluarga maksud pemasangan stiker dan penanda tersebut tersebut.
 - e. Pengkajian ulang dilakukan oleh perawat secara berkala setiap hari atau jika terjadi perubahan kondisi pasien atau pengobatan.
 - f. Jika ada pasien jatuh dilakukan tatalaksana pasien jatuh dan membua tlaporan insiden keselamatan pasien.

9.6 Tata Laksana Pada Pasien Unti Intensive

1. Memberikan pertolongan pertama sesuai dengan kondisi yang terjadi pada pasien
2. Melaporkan pada dokter jaga ruangan/ IGD
3. Memberikan tindakan sesuai dengan instruksi dokter jaga
4. Mengobservasi keadaan umum pasien

-
5. Mendokumentasikan kejadian tersebut pada formulir “Pelaporan Insiden Keselamatan”

BAB X

KESELAMATAN KERJA

10.1 Latar Belakang

Rumah sakit merupakan tempat kerja yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian risiko yang berkaitan dengan keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit agar terciptanya kondisi Rumah Sakit yang sehat, aman, selamat, dan nyaman bagi sumber daya manusia Rumah Sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan Rumah Sakit, maka Rumah Sakit perlu menerapkan SMK3 Rumah Sakit. SMK3 Rumah Sakit merupakan bagiandari sistem manajemen Rumah Sakit secara keseluruhan

10.2 Pengertian

Keselamatan kerja merupakan suatu sistem dimana rumah sakit membuat kerja / aktifitas karyawan lebih aman. Sistem tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan pribadi ataupun rumah sakit.

10.3 Tujuan

1. Terciptanya budaya keselamatan kerja di RS PRIMA HUSADA
2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan
3. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya.
4. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahayakecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

10.4 Tata Laksana Keselamatan Karyawan.

1. Setiap petugas medis maupun non medis menjalankan prinsip pencegahan infeksi, yaitu:
 - a. Menganggap bahwa pasien maupun dirinya sendiri dapat menularkan infeksi.
 - b. Menggunakan alat pelindung (sarung tangan, kacamata, sepatu boot/alas kakitertutup, celemek, masker dll) terutama bila terdapat kontak dengan spesimen pasien yaitu: urin, darah, muntah, sekret, dll.
 - c. Melakukan perasat yang aman bagi petugas maupun pasien, sesuai prosedur yang ada, mis: memasang kateter, menyuntik, menjahit luka, memasang infus, dll
 - d. Mencuci tangan dengan sabun antiseptik sebelum dan sesudah menangani pasien.
2. Terdapat tempat sampah infeksius dan non infeksius
3. Mengelola alat dengan mengindahkan prinsip sterilitas yaitu:
 - a. Dekontaminasi dengan larutan klorin
 - b. Pencucian dengan sabun
 - c. Pengeringan
4. Menggunakan baju kerja yang bersih
5. Melakukan upaya-upaya medis yang tepat dalam menangani kasus :
 - a. HIV / AIDS (sesuai prinsip pencegahan infeksi)
 - b. Flu burung

Kewaspadaan standar karyawan / petugas IGD dalam menghadapi penderita

dengan dugaan flu burung adalah :

1) Cuci tangan

Cuci tangan dilakukan dibawah air mengalir dengan menggunakan sikat selama $\pm$ 5 menit, yaitu dengan menyikat seluruh telapak tangan maupun punggung tangan.

2) Hal ini dilakukan sebelum dan sesudah memeriksa penderita.

3) Memakai masker N95 atau minimal masker badan

4) Menggunakan pelindung wajah / kaca mata goggle (bila diperlukan)

5) Menggunakan apron / gaun pelindung

6) Menggunakan sarung tangan

7) Menggunakan pelindung kaki (sepatu boot)

c. Hepatitis B / C (sesuai prinsip pencegahan infeksi)

10.5 Prinsip Keselamatan Kerja

Prinsip utama prosedur Universal Precaution dalam kaitan keselamatan kerja adalah menjaga higiene sanitasi individu, higiene sanitasi ruangan dan sterilisasi peralatan. Ketiga prinsip tersebut dijabarkan menjadi 5 (lima) kegiatan pokok yaitu :

1. Cuci tangan guna mencegah infeksi silang
2. Pemakaian alat pelindung diantaranya pemakaian sarung tangan guna mencegah kontak dengan darah serta cairan infeksi yang lain.
3. Pengelolaan alat kesehatan bekas pakai.
4. Pengelolaan jarum dan alat tajam untuk mencegah perlukaan.
5. Pengelolaan limbah dan sanitasi ruangan.

BAB XI

PENINGKATAN MUTU

11.1 Prinsip

Prinsip dasar upaya peningkatan mutu pelayanan adalah pemilihan aspek yang akan ditingkatkan dengan menetapkan indikator, kriteria serta standar yang digunakan untuk mengukur mutu pelayanan Rumah Sakit.

11.2 Definisi Indikator

Indikator merupakan suatu variabel yang digunakan untuk bisa melihat perubahan. Indikator yang baik adalah yang sensitif tapi juga spesifik.

11.3 Kriteria

Spesifikasi dari indikator.

11.4 Standar

Tingkat performance atau keadaan yang dapat diterima oleh seseorang yang berwenang dalam situasi tersebut, atau oleh mereka yang bertanggungjawab untuk mempertahankan tingkat performance atau kondisi tersebut. Suatu norma atau persetujuan mengenai keadaan atau prestasi yang sangat baik. Sesuatu ukuran ataupun tolok untuk mengukur kuantitas, berat, nilai atau mutu. Dalam melaksanakan upaya peningkatan mutu pelayanan maka harus memperhatikan prinsip dasar sebagai berikut:

1. Aspek yang dipilih untuk ditingkatkan
 - a. Keprofesian
 - b. Efisiensi
 - c. Keamanan pasien
 - d. Kepuasan pasien
 - e. Sarana dan lingkungan fisik
2. Indikator yang dipilih
 - a. Indikator lebih diutamakan untuk menilai output daripada input dan proses.
 - b. Bersifat umum, yaitu lebih baik indikator untuk situasi dan kelompok daripada untuk perorangan.
 - c. Dapat digunakan untuk membandingkan antar daerah dan antar Rumah Sakit.
 - d. Dapat mendorong intervensi sejak tahap awal pada aspek yang dipilih untuk di monitor.
 - e. Didasarkan pada data yang ada.

Beberapa indikator mutu dalam pelayanan Intensive Care Unit (ICU) sebagai berikut :

 - 1) Kejadian petugas tertusuk benda tajam
Yaitu petugas yang terkena benda tajam seperti jarum, pecahan kaca/ ampul atau benda tajam lainnya saat melakukan tindakan medis selama di lingkungan rumah sakit.
 - 2) Kejadian tidak dilakukannya pengkajian kriteria keluar masuk ICU pada pasien perawatan ICU
Yaitu penyesuaian keadaan pasien dengan kriteria keluar masuk ICU
 - 3) Kejadian di transfernya pasien tidak stabil ke ICU
Yaitu jumlah banyaknya kejadian di transfernya pasien tidak stabil ke ICU.

Analisis harus dilakukan secara berkala setiap hari dan dilakukan pelaporan selama 1 bulan sekali serta dilakukan frekuensi data selama triwulan. Dan harus disimpulkan dari analisis ini adalah kecenderungan (trend) dari setiap indikator.

3. Kriteria

Kriteria yang digunakan harus dapat diukur dan dihitung untuk dapat menilai indikator, sehingga dapat sebagai batas yang memisahkan antara mutu baik dan mutu tidak baik.

4. Standar yang digunakan

- a. Acuan dari berbagai sumber.
- b. Berdasarkan trend yang menuju kebaikan.

BAB X PENUTUP

Pedoman Unit Intensive disusun dalam rangka memberikan acuan bagi RumahSakit yang telah maupun akan menyelenggarakan pelayanan ICU dan HCU yang bermutu, aman, efektif dengan mengutamakan keselamatan pasien. Oleh karena itu setiap rumah sakit diharapkan dapat menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalambuku pedoman ini dan dapat mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan rumah sakit.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 04 April 2025
Direktur RS PrimaHusada



dr. Nur Mazidah